

주 의 사 항

1. 제 목 : 진료수가 관리업무 부적정

2. 관계기관 : ○○·☆☆☆☆병원

3. 내 용 : ☆☆☆☆병원에서는 「건강보험 행위 급여·비급여 목록표 및 급여 상대가치점수(보건복지부 고시)」를 근거로 하여 진료비를 산정하기 위해 통합 EMR시스템으로 진료수가를 관리하고 있습니다.

보훈병원의 진료비 계산은 환자수납과 보험청구가 다르게 운영되고 있으며 계산방식은 [표 1]과 같이 운영되고 있습니다.

[표 1] 진료비 계산 방식 현황

구 분	계산방식
환자수납 진료비	1. 수가의 입력된 상대가치 점수 있을 경우 - 상대가치 점수 × 점수당 단가 × 사용량
	2. 수가의 입력된 상대가치 점수 없을 경우 - 진료단가 × 사용량
보험청구 진료비	수가의 입력된 EDI코드에 해당 진료단가 × 사용량

건강보험 행위 급여비용은 행위별 분류별로 상대가치점수가 정해져 있으며, 점수당 단가는 정기적으로 매년 1월 1일에 인상하여 요양기관 종별로 점수당 단가를 고시하고 있으며, 상대가치점수와 점수당 단가를 곱하여 진료단가가 산정되며, 병원에서는 통합EMR시스템의 수가관리 프로그램을 이용하여 상대가치점수와 점수당 단가를 변경하여 수가를 관리하고 있습니다.

한편, 전혈 및 혈액성분제제료의 수가는 [표 2]와 같이 상대가치 점수와 점수당 단가가 적용되지 않고 「혈액관리법」 제11조의 규정에 의하여 장관이 별도 고시한 항목과 금액을 적용하도록 규정하고 있습니다.

[표 2] 전혈 및 혈액성분제제료 수가 예시('17. 1. 1. 기준)

구 분	상대가치 점수 단가	고시 단가	차액
농적혈구 전혈 320ml	43,471원 (상대가치 점수 601.26 * 점수당 단가 72.3원)	46,360원	2,889원

따라서, ☆☆☆☆병원에서는 보건복지부의 행위 및 재료에 대한 신설 및 변경사항이 고시될 경우 통합EMR시스템상의 수가를 적기에 정확하게 변경하여 정당한 진료비가 산정될 수 있도록 관리하여 병원 수입에 문제가 발생하지 않도록 관리하여야 합니다.

그런데 ☆☆☆☆병원의 진료행위별 진료비 산정내역을 확인한 결과, 일부 전혈 및 혈액성분제제료의 수납 단가보다 실제 받을 금액이 적게 계산되어 확인해보니 전혈 및 혈액성분제제료의 수가에 상대가치 점수를 입력하여 수가코드에 입력된 진료단가가 아닌 상대가치점수와 점수당 단가를 곱하여 계산되어 [표 3]과 같이 환자에게 700건 172,567원이 적게 수납되었으며, 같은 방식으로 ○○○○병원에서도 666건 161,706원이 적게 수납되었으나, 보험자부담금 청구액은 정상적인 수가의 단가로 계산된 금액으로 청구된 것이 확인되었습니다.

[표 3] 전혈 및 혈액성분제제 진료비 착오 수납 현황

(단위 : 건/원)

구분	건수	착오 금액	정상 금액	차액	환자수납 착오금액
☆☆병원	700	31,723,230	30,006,460	1,716,770	172,567
○○병원	666	32,647,010	30,615,390	2,031,620	161,706
계	1,366	64,370,240	60,621,850	3,748,390	334,273

4. 조치할 사항

○ ○○·☆☆☆☆병원장은

- 진료수가 신규 및 변경되어 통합EMR시스템 수가를 수정할 경우 정확한 진료비가 산정될 수 있도록 모의 수납작업 등 사전 검토절차를 철저히 하여 주시기 바람(통보)
- 앞으로 동일 사례가 발생하지 않도록 관련자에게 「주의」 조치하시기 바랍니다. (주의)